

Mioma uterino · sangramento e cirurgia

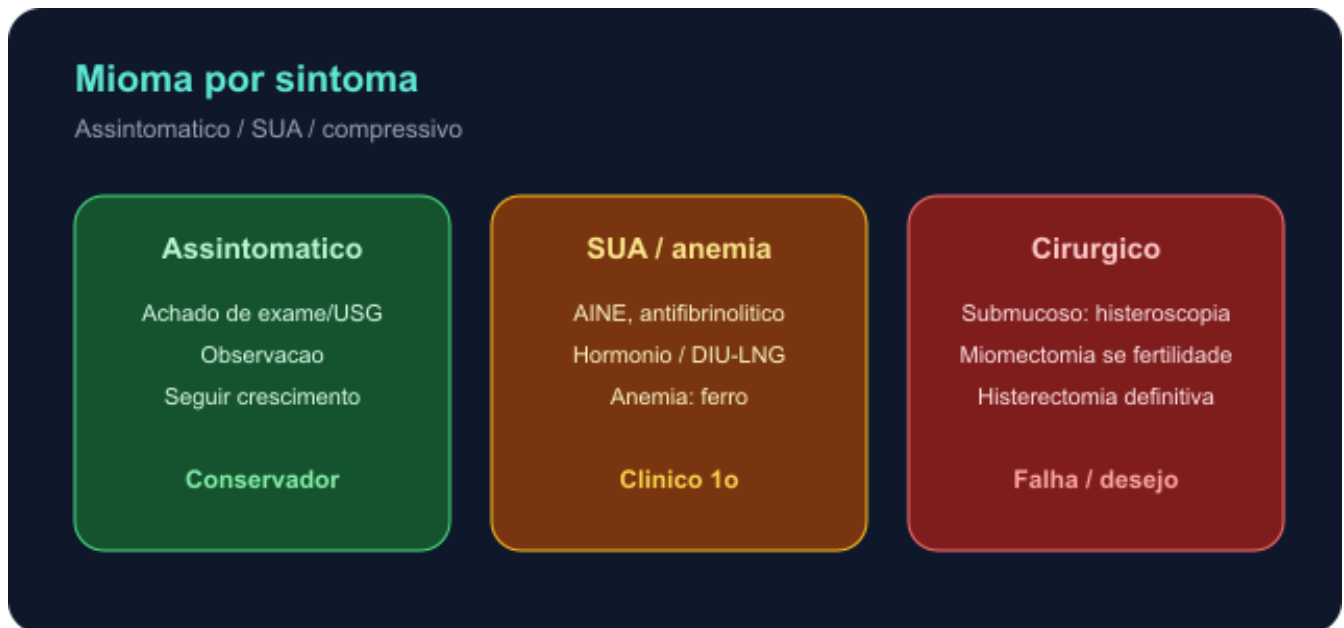
Leiomioma é causa comum de sangramento uterino anormal e massa pélvica. Conduta segue sintomas, desejo reprodutivo e localização (submucoso sangra mais).

Localização

Lembre - Localização

Submucoso (FIGO 0–2): sangramento. Intramural: volume/SUA. Subseroso: compressão. Pediculado pode torcer (abdome agudo).

Assintomático observa; SUA trata clinicamente; falha ou compressão caminha para procedimento.



Pontos de prova

- USG pélvico é 1ª imagem; RNM se mapeamento cirúrgico complexo
- DIU-LNG e agonistas de GnRH reduzem sangramento (GnRH temporário)
- Embolização: opção em selecionadas sem desejo imediato de gestar
- Crescimento rápido na pós-menopausa: excluir sarcoma (raro, mas cai)

Procedimento × objetivo

Objetivo | Opção

Preservar útero/fertilidade | Miomectomia
Submucoso sangrante | Histeroscopia resectoscópica
Definitivo sem fertilidade | Histerectomia
Má candidato cirúrgico | Embolização / clínico

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

SUA em >45 anos ou com critérios de risco: excluir hiperplasia/câncer de endométrio antes de atribuir tudo a mioma.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Mioma: classificação FIGO (0–8) pela relação com endométrio/serosa e indicações cirúrgicas clássicas.

FIGO mioma (ideia)

Tipos 0-8 por localização

0 - pediculado intracavitário	submuc
1 - <50% intramural	submuc
2 - ≥50% intramural	submuc
3-5 - contato endométrio / intramural	intra
6-7 - subseroso (+/- pedículo)	subser
8 - cervical / parasita / outros	outro

0-2 submucosos | 3-5 intramurais | 6-7 subserosos | 8 outros

Indicações clássicas de cirurgia

- Sangramento refratário / anemia sintomática
- Dor ou compressão (bexiga, ureter, intestino) refratária
- Infertilidade/aborto relacionados a mioma submucoso (ou distorção cavidade)
- Crescimento rápido suspeito / dúvida com sarcoma (raro, mas banca cita)
- Mioma pediculado torsionado / necrose sintomática

Via — ideia rápida

Cenário | Opção clássica

Submucoso 0–1 sintomático | Histeroscopia (miomectomia)

Desejo reprodutivo + intramural | Miomectomia (aberta/laparoscópica)

Multipara, sintomas refratários, sem desejo gestacional | Histerectomia

Urgência hemorrágica | Estabilizar ± cirurgia conforme recurso

Prova

Dica - Prova

Submucoso sangra mais; subseroso comprime. FIGO ajuda a escolher histeroscopia vs miomectomia/histerectomia.